

在患者疼痛感受,治疗体验,血污染情况等方面优势明显,值得在临床工作中推广。

参考文献

- [1] 杨方方,向琪,王顺清,等.真性红细胞增多症的临床特征和血栓危险因素分析[J].血栓与止血学,2015,2(4):225-228.
- [2] 葛均波,徐永健.内科学[M].北京:人民卫生出版社,2013:608.
- [3] Tefferi A, Vardiman JW. Classification and diagnosis of myeloproliferative neoplasms: the 2008 World Health Organization criteria and point-of-care diagnostic algorithm [J]. Leukemia, 2008, 22(1): 14-22.
- [4] 童莺歌,成燕,刘冬华,等.术后疼痛护理评分与患者静息及活动性疼痛自评结果的比较[J].护理学杂志,2015,30(6):15-17.
- [5] 蒋艳娟,钟华.无偿献血采血过程中血源性污染环节的防控[J].中国中医药现代远程教育,2012,10(12):156-157.

• 经验交流 • doi:10.3969/j.issn.1671-8348.2017.04.033

- [6] 杜俊英,徐晶,刘静华.真红细胞增多症静脉放血的护理[J].中国实用医药杂志,2007,2(7):120-121.
- [7] 陈燕辉,张瑞春.改良胃肠减压器在真性红细胞增多症患者静脉放血中的应用[J].齐鲁护理杂志,2013,19(8):23-24.
- [8] 张颖,李佳宁,杜天顺,等.对比不同静脉放血方法治疗真性红细胞增多症的临床效果[J].现代生物医学进展,2014,8(8):1562-1564.
- [9] 王平.真性红细胞增多症静脉放血的方法[J].科技信息,2013,30(1):477.
- [10] 张洪,余芳.真性红细胞增多症护理体会[J].中医药临床杂志,2011,23(11):334-335.
- [11] 朱大年,王庭槐.生理学[M].北京:人民卫生出版社,2013:102.
- [12] 贾丽苹,王咏梅,蒋蓉,等.透析套管针与钢针用于内瘘穿刺效果比较[J].护理学杂志,2014,29(11):1-4.

(收稿日期:2016-09-20 修回日期:2016-10-28)

42 例腹壁硬纤维瘤的诊断与治疗分析*

林维浩,李杰,王天宝

(中山大学附属第一医院普通外科,广州 510080)

[摘要] 目的 探讨腹壁硬纤维瘤的诊断与治疗,提高对该病的诊治水平。方法 回顾性分析该院 2004 年 6 月至 2014 年 10 月收治的 42 例腹壁硬纤维瘤患者的临床资料。42 例中术前确诊 35 例,7 例首诊中误诊,误诊率为 16.7%。7 例误诊患者术后病理确诊。首次手术 39 例,其中治愈 32 例,7 例术后复发;外院术后复发 3 例,治愈 2 例,1 例因术后局部再次复发而拒绝手术。结果 采用恰当的手术方式可减少腹壁硬纤维瘤的复发;口服三苯氧胺及化疗降低了该病的复发率。结论 腹壁硬纤维瘤具有局部侵袭性、易复发。术前避免误诊,外科手术治疗是腹壁硬纤维瘤唯一有效手段。

[关键词] 纤维瘤病,侵袭型;腹壁;早期诊断;治疗结果;外科手术

[中图分类号] R735.5

[文献标识码] B

[文章编号] 1671-8348(2017)04-0526-03

腹壁硬纤维瘤是一种临床上少见的交界性肿瘤,它来源于腹壁筋膜和肌肉等软组织,具有侵袭性、易复发性及局部破坏性^[1],好发于中青年女性。因其在临床上少见,容易导致误诊。对本院 2004 年 6 月至 2014 年 10 月收治 42 例腹壁硬纤维瘤患者的临床资料进行回顾性分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本组患者 42 例,男 12 例,女 30 例,年龄 16~49 岁,平均年龄 34.6 岁,中位年龄 37.4 岁。其中外院术后复发 3 例,有生育史 18 例,有腹部手术史 22 例,腹部外伤史 4 例,2 例有家族性腺瘤样息肉病史(表 1)。42 例表现为腹部实性肿块,边界不清,质硬,不活动。病灶小于 5 cm 28 例,5~10 cm 10 例,>10 cm 4 例。病程:10 d 至 4.5 年,平均 1.8 年。肿瘤位于上腹部 12 例,下腹部 30 例。其中 6 例因肿块较大,伴有局部疼痛不适;7 例因侵犯腹腔脏器,伴有腹痛。35 例首诊确诊,7 例首诊误诊,误诊率为 16.7%。误诊疾病:3 例误诊为脂肪瘤,2 例误诊为神经纤维瘤,2 例误诊为结肠癌腹壁转移。42 例患者行腹部 B 超检查,均发现腹壁有实性占位病变,部分呈囊性改变。30 例发现肿块边界清,无局部侵犯;12 例肿块边界不清,有局部侵犯表现。38 例行腹部 CT 检查,16 例腹

壁硬纤维瘤呈不均匀改变,周围及内部见供血血管丰富,边界清,与周围脂肪间隙存在。12 例合并腹腔内脏器受压或脏器侵犯。

表 1 42 例腹壁硬纤维瘤的病史情况(n=42)

病史	n	百分率(%)
腹部手术病史	22	52.4
剖腹产	10	23.8
阑尾切除术	2	4.8
结肠癌根治术	1	2.4
胃癌根治术	5	11.9
胃大部分切除术	4	9.5
腹壁外伤	4	9.5
生育史	18	42.9
家族性腺瘤样息肉病史	2	4.8
原因不明	6	16.7

1.2 方法 42 例患者均行手术治疗。首次手术 39 例,手术方法为腹壁肿块切除术、腹壁扩大切除+腹壁补片修补术、腹

壁肿块切除术+横结肠切除术和腹壁肿块切除术+升结肠切除术+腹壁补片修补术。治愈 32 例,7 例术后复发而再次手术;再次手术方式为腹壁扩大切除+腹壁补片修补术。外院术后复发 3 例,手术方式为腹壁扩大切除+腹壁补片修补术和腹壁肿块切除+乙状结肠切除术,2 例治愈,1 例术后局部再次复发后拒绝手术。腹壁缺损面积较少者,采用聚四氟乙烯补片修复腹壁缺损;对腹壁缺损较大者,采用生物补片与聚四氟乙烯补片双层材料修复缺损,术后放置引流管。25 例雌激素阳性患者,术后予以三苯氧胺治疗;7 例脏器侵犯的患者,予以长春新碱+氨甲蝶呤方案化疗。

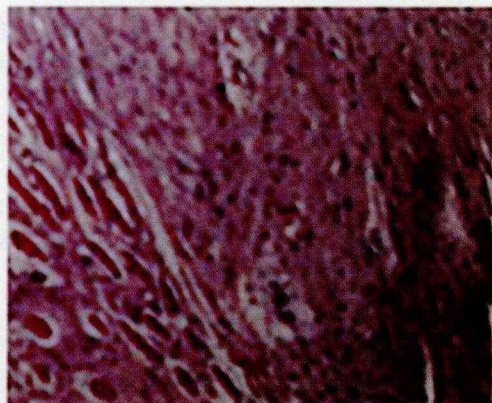
2 结 果

2.1 大体病理表现 肿块大小不等,无包膜,边界不清,向周围组织浸润性生长,切面呈灰白色,纤维束呈条索状排列(图 1)。镜下:肿块由成纤维细胞增生和胶原纤维构成,成纤维细胞及纤维之间呈交错排列,胶原纤维在细胞之间穿插(图 2)。免疫组织化学:25 例 ER(+),PR(+).



肿块大小约 7 cm×6 cm×4 cm,切面灰白。

图 1 腹壁硬纤维瘤切除术后大体标本



肿瘤由编织状的梭形细胞构成,并浸润至横纹肌,细胞无明显异型性,仅见个别裂。

图 2 腹壁硬纤维瘤切除术后病理标本

2.2 随访结果 术后随访 1~16 年,平均 5.6 年,采用门诊复诊、电话或信件等方式随访,随访率 100%。结果 39 例首次手术患者,其中 7 例复发,复发时间为 0.9~3.4 年,平均 1.74 年;外院术后复发 3 例,1 例再次手术后复发时间为 1.6 年。口服三苯氧胺治疗的 25 例,7 例复发再次手术,复发率为 28%。化疗 7 例患者,术后随访期间,未见复发。随访病例未见有死亡。

3 讨 论

硬纤维瘤也称为侵袭性纤维瘤、韧带样瘤,是一种罕见的

良性肌腱膜过度增生,可以发生在全身任何部位^[2-3]。该病在组织学上虽无明显恶性特征,无淋巴及血液转移,但具有侵袭性、易复发及局部组织破坏。在临床上,介于良性和恶性肿瘤之间,目前大多数学者认为该病为交界性肿瘤。其发病率为 2~5/100 万,但在家族性腺瘤样息肉患者中发病率可高达 8%~38%^[4]。约占全身软组织肿瘤的 0.03%~3.00%。临床上以脐下腹壁为多见,约占该病的 2/3。本组 42 例中,下腹部 30 例,占 71.4%。主要侵犯腹壁、筋膜鞘和肌层。按生长部位分为三类:腹外型、腹壁型和腹内型^[4]。

本病好发于女性妊娠生育后、腹部手术及腹壁外伤。部分患者合并有家族性腺瘤样息肉病史。腹壁硬纤维瘤发病原因尚不明确,与腹壁损伤、内分泌失调及遗传因素有关。目前认为腹壁损伤是本病的主要因素之一^[5]。

腹壁硬纤维瘤临床上主要表现为腹壁肿块,边界不清,质硬,不活动。生长缓慢,大多数无明显症状,一般无疼痛或偶有不适。少数发展为巨大腹壁硬纤维瘤或侵犯腹腔脏器,引起肠梗阻。由于早期腹壁硬纤维瘤临床上症状不明显,容易误诊为脂肪瘤、神经纤维瘤及纤维肉瘤。特别有癌症手术病史的患者,容易误诊为肿瘤腹壁转移。本组 42 例中,35 例首诊确诊,7 例首诊误诊,误诊率为 16.7%。分别误诊为脂肪瘤,神经纤维瘤和结肠癌腹壁转移。

影像学检查对诊断腹壁硬纤维瘤具有重要价值。B 超检查是一种安全简便、费用低廉的检查。可以作为术前筛选手段之一。B 超能够确定肿瘤在腹壁组织内大小、位置及病变范围,并有助于鉴别腹腔内肿块^[6-7]。CT 检查能够显示肿瘤的来源、边界及侵犯腹腔脏器情况。然而当肿瘤较小时,CT 检查在一定程度上受限,难以分辨病灶与正常肌肉^[8]。MRI 对诊断腹壁硬纤维瘤有重要帮助,较 CT 检查更能显示病灶的部位、大小、形态和病灶边缘情况,但其价格昂贵,难以在基层医院推广。

腹壁硬纤维瘤的治疗上,目前存在一定争议。有人认为该病是一种良性肿瘤,术后有较高的复发率,不主张手术治疗^[9]。然而经过长期临床实践总结认为,手术彻底切除病灶是惟一可靠的手段^[10-11]。手术治疗上应该做到早诊断、早治疗,应避免保守治疗导致延误病情。关于在选择手术方法上也存在争议,有学者认为术后复发与手术范围无关,手术切除肉眼所见病变即可,即使切缘为阳性,也不一定复发。笔者认为腹壁硬纤维瘤必须在完整切除瘤体基础上,将肿瘤边缘 2~3 cm 的周边正常组织,如肌肉、腱膜和腹膜一并切除,并取周边多点正常组织送冰冻病理检查,避免有肿瘤组织残留。特别在纵轴方向切缘应距离肿瘤 2~3 cm 以上,这一点有利于防止腹壁硬纤维瘤术后复发。上述 42 例手术患者中,术后复发的患者,大部分与首次手术切除有关。对于巨大腹壁硬纤维瘤治疗,广泛切除肿瘤后存在较大的腹壁缺损,应注意腹壁功能的重建。修补腹壁缺损时应注意补片的选择,选用与人体组织排斥少的补片材料,术后注意引流,避免术后创面积液感染;应注意补片的张力和固定,避免腹壁修复失败。在修复过程中,若创面存在有感染或污染,应考虑二期修复腹壁缺损。

腹壁硬纤维瘤术后是否予以内分泌治疗和化疗目前仍有争论^[12-13]。虽然基础研究发现腹壁硬纤维瘤与雌激素有关^[12],但是上述 25 例雌激素阳性患者中,予以三苯氧胺治疗,术后仍有较高的复发率。内分泌治疗的效果仍要待进一步观察。7 例脏器侵犯的患者,术后予以长春新碱+氨甲蝶呤化疗,对患者随访未发现复发。化疗对腹壁硬纤维瘤治疗效果,

仍需要大样本、长时间的观察给予验证。

参考文献

- [1] 尹森琴,刘勇强,张国正. 腹壁硬纤维瘤的临床特点与 CT 表现[J]. 浙江实用医学,2014,19(5):359-361.
- [2] Meyerson SL,D'Amico TA. Intrathoracic desmoid tumor: brief report and review of literature[J]. J Thorac Oncol, 2008,3(6):656-661.
- [3] Catania G,Ruggeri L,Iuppa G,et al. Abdominal wall reconstruction with intraperitoneal prosthesis in desmoid tumors surgery[J]. Updata Surg,2012,64(1):43-48.
- [4] Shinagare AB,Ramaiya NH,Jagannathan JP,et al. A to Z of desmoid tumors[J]. AJR AM J Roentgenol,2011,197(6):1008-1014.
- [5] Wong SL. Diagnosis and management of desmoid tumors and fibrosarcoma[J]. J Surg Oncol,2008,97(6):554-558.
- [6] 陈坤,张增芳,王克,等. 腹壁韧带样瘤的临床与超声分析[J]. 中华肿瘤防治杂志,2011,18(12):965-967.
- [7] 焦丹,田稳,隋国庆. 腹壁韧带样瘤的超声诊断价值[J].

• 经验交流 • doi:10.3969/j.issn.1671-8348.2017.04.034

中国实验诊断,2015,19(8):1412-1413.

- [8] 严骏燕,刘金有. CT 对腹壁韧带样瘤的诊断价值[J/CD]. 中华疝和腹壁外科杂志(电子版),2014,8(2):116-118.
- [9] Galdwell EH. Desmoid tumor: musculoaponeurotic fibrosis of the abdominal wall[J]. Surgery,1976,79(1):104-106.
- [10] 孙志国,王猛,朱卫红. 腹壁韧带样瘤 16 例临床分析[J/CD]. 中华疝和腹壁外科杂志(电子版),2012,6(1):578-581.
- [11] 顾伟青,王强,杨徐雄. 腹壁韧带样瘤诊治特点[J]. 齐齐哈尔医学院学报,2012,33(21):2902-2903.
- [12] 杨小梅,乔宠,周颖,等. 妊娠期妇女腹壁韧带样瘤 1 例报告并文献复习[J]. 中国实用妇科与产科杂志,2014,30(4):308-311.
- [13] 黄恺. 韧带样瘤诊治进展及热点问题[J]. 中国癌症杂志,2010,20(3):227-230.

(收稿日期:2016-09-21 修回日期:2016-10-19)

医学生心理资本与家庭满意度的关系研究

周丽,赖文,廖雪萍,石素芝,林凤,李绪莉

(攀枝花学院医学院,四川攀枝花 617000)

[摘要] 目的 了解医学生心理资本及家庭满意度的现状及两者的相关性。方法 采用积极心理资本问卷,家庭满意度问卷对 150 名医学生进行调查。结果 (1)医学生的心理资本的自我效能、希望、韧性及乐观得分分别为 (31.35 ± 5.06) 、 (29.5 ± 3.63) 、 (29.2 ± 4.65) 、 (28.9 ± 5.45) 分,医学生的家庭满意度的家庭教养方式、家庭成员的沟通了解、家庭环境得分分别为 (25.5 ± 4.70) 、 (27.8 ± 6.87) 、 (42.3 ± 8.80) 分,均在中点以上。(2)医学生的心理资本的自我效能、希望与家庭满意度各因子,韧性与家庭教养方式因子,乐观与家庭教养方式和家庭成员的沟通了解因子呈正相关关系($P < 0.05$)。结论 医学生的心理资本状况相对较好。家庭环境、家庭成员的沟通了解和家庭教养方式是影响其心理资本的重要因素,提高医学生对家庭的满意度有助于提高和改善其心理资本。

[关键词] 学生;医科;心理资本;家庭满意度

[中图分类号] B849

[文献标识码] B

[文章编号] 1671-8348(2017)04-0528-03

随着社会的进步、社会竞争越来越激烈,在社会与学校间跨度的大学生也承受着越来越多的压力。家庭的期待、情感的成熟、学业的压力、生活与就业的压力等众多的问题困扰着大学生,焦虑、抑郁、敌对等心理问题随之出现得也越来越多,因此大学生的心理健康受到广泛的社会关注。心理资本是 Luthans 等^[1]2002 年在积极心理学和积极组织行为的框架下提出的,是“个体在成长和发展过程中呈现出来的一种积极心理状态”,既往研究发现大学生心理健康与心理资本密切相关,大学生心理资本的得分越高,越具备积极的心理能力,其心理健康的水平越高^[2-4]。因此提高大学生的心理资本对提高大学生心理健康水平起到重要作用。医学生承受着比别的专业更重的学业与责任,良好的心理资本对其显得尤为重要。作为个体所拥有的积极心理资源,可通过开发和管理提升心理资本^[4]。而家庭是每个孩子走向社会的港口,家庭是影响个体心理品质极其重要的因素。那么家庭与心理资本存在着怎样的关系?家庭是否影响学生心理资本形成和提升?本文对此进

行研究,希望找到影响医学生心理资本积累的因素及途径,从而挖掘学生潜能,促进医学生的心理健康。

1 资料与方法

1.1 一般资料 依据既往医学生心理相关研究^[5-6]进行统计学样本估计后,从四川省某医学院校,按整群随机抽样法抽出 4 个班级的学生进行问卷调查,收回问卷 150 份。除一份无效问卷,有效问卷 149 份。其中男生 67 名、女生 82 名;年龄 18~22 岁,平均 (19.79 ± 2.42) 岁。

1.2 方法

1.2.1 积极心理资本问卷^[7] 问卷包括 4 个维度:分别为自我效能、韧性、希望、乐观。题目的评价按 Likert 式七点量表进行。该量表的内部一致性 α 系数全量表为 0.79,自我效能、韧性、希望、乐观均在 0.70 以上,全量表及各分量表具有良好的信、效度。

1.2.2 家庭满意度问卷^[8] 量表由 23 个条目组成,包括家庭教养方式,家庭成员的沟通了解和家庭环境 3 个因子。对问卷